

Mais acesso, piores resultados

Case Challenge

Objetivo do exercício

Em grupo, vais construir um *Problem Statement* defensável para um programa público com um paradoxo real: houve aumento de acesso, mas os *outcomes* e a pressão no sistema não melhoraram de forma clara. No final, cada grupo apresenta a sua versão em 60 segundos.

Contexto

Um município (≈ 150 mil habitantes) lançou o programa “Consulta Agora” para reduzir barreiras de acesso aos cuidados de saúde primários e à saúde mental, com três medidas em simultâneo:

1. Teleconsulta e *chat* de triagem (em parceria com uma *healthtech*)
2. Unidades móveis semanais em bairros periféricos
3. Linha municipal de apoio psicossocial com encaminhamento

O programa é elogiado publicamente por ter aumentado o acesso. No entanto, 6 meses depois, surgiram sinais contraditórios:

- As listas de espera presenciais não parecem cair de forma consistente
- A equipa clínica reporta aumento de carga administrativa e rotatividade
- A urgência hospitalar reporta que a pressão não diminuiu
- Organizações comunitárias dizem que o programa não chega a quem mais precisa

O município quer preparar um piloto de 8-12 semanas para corrigir o rumo, sem aumentar orçamento e com atenção a privacidade e dados sensíveis.

Restrições do piloto (não negociáveis)

- Duração: 8-12 semanas
- Sem aumento de *budget* e sem contratação de novos profissionais
- Dados: recolha limitada e com privacidade (preferir dados agregados/anonimizados)
- Implementação: tem de caber no sistema real (sem “produto perfeito”)

Stakeholders (incentivos em conflito)

- Município (político): quer mostrar “mais acesso” e reduzir reclamações
- Cuidados primários (operacional): quer reduzir duplicações e melhorar fluxo
- Hospital/urgência: quer reduzir procura evitável
- Comunidades vulneráveis: querem confiança, continuidade e suporte humano
- Fornecedor tech: quer crescimento de utilização e *engagement*
- Proteção de dados: limita centralização e partilha de informação sensível

O Paradoxo

Acesso aumentou, mas o sistema está mais pressionado e os *outcomes* não melhoraram de forma clara. O programa pode estar a falhar por um de vários mecanismos possíveis, mas o vosso grupo terá de escolher um foco para construir um problema recortado e observável.

Tarefa do grupo (30 minutos)

1. Escolher UM recorte (obrigatório)

- a. Escolham um destes focos:
 - i. “Acesso sem resolução”: O canal aumenta contactos, mas não resolve (baixa resolução no primeiro contacto).
 - ii. “Duplicação e fragmentação”: As pessoas entram por múltiplas portas e repetem o mesmo tema/caso.
 - iii. “Exclusão invisível”: Quem mais precisa não usa, não confia ou não consegue aceder (desigualdade digital).
 - iv. “Burnout e degradação do serviço”: O programa aumenta carga, reduz qualidade e gera mais retornos/escalada.

2. Pesquisa rápida (online)

- a. O grupo deve recolher referências para sustentar o *Problem Statement*. No mínimo, tragam:
 - i. 1 a 2 fontes sobre procura induzida/efeitos da telemedicina no volume de procura
 - ii. 1 fonte sobre desigualdade digital e acesso a cuidados/serviços
 - iii. 1 referência sobre métricas úteis (ex.: resolução no primeiro contacto, repetição, escalada, *no-show*, etc.)

As fontes devem ser citadas de forma simples (link ou referência).

3. Produzir o *Problem Statement* final

- a. Segmento e contexto (quem, onde, em que ponto do fluxo de cuidado)
- b. Problema observável (o que falha)
- c. 1 a 2 números de magnitude com fonte (podem ser *proxies*, desde que citados)
- d. *Status quo* e porque falha
- e. Uma hipótese causal (o mecanismo provável)
- f. 1 pergunta crítica em aberto que orienta o piloto

4. Preparar apresentação

- a. Cada grupo apresenta em 2 minutos:
 - i. lê o *Problem Statement*
 - ii. diz o(s) número(s) e a(s) fonte(s)
 - iii. diz a pergunta crítica em aberto